Sujet SDD 34

Spécialité : Chirurgie orthopédique et traumatologique

Date : 24/01/2026
Auteur : Yann SEBAIS, interne d'orthopédie à Rouen
Relecteur(s) : Pr Matthieu LALEVEE (PUPH Orthopédie Rouen), Hamza MAKHLOUK (VP ECOS TACFA, interne en cardiologie à Paris)

Domaine d'apprentissage principal	Examen clinique
Domaines d'apprentissage secondaire	Stratégie diagnostique Stratégie pertinente de la prise en charge Urgence vitale
Items en lien avec la station	363- Fractures fréquentes de l'adulte et du sujet âgé 362- Prothèses et ostéosynthèses
Situation de départ en lien avec la station	34- Douleur aiguë post-opératoire
Matériel nécessaire à la station	Aucun
Contexte de la station	Avec patient standardisé Chambre d'hospitalisation

Pour rappel, les domaines d'apprentissage sont :

- Entretien/interrogatoire
- Examen clinique
- Iconographie
- Procédure
- Stratégie diagnostique
- Stratégie pertinente de la prise en charge
- Synthèse des résultats d'examens paracliniques
- Education/prévention
- Annonce/information au patient
- Urgence vitale
- Communication interprofessionnelle

La liste des items de l'EDN se trouve ICI
La liste des situations de départ se trouve ICI

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Il est 23h, vous êtes un.e interne de garde en chirurgie traumatologique et orthopédique.
Vous êtes appelé dans la nuit par un(e) IDE de votre service au sujet d'une patiente hospitalisée ce matin et opérée par un collègue cette après-midi. La patiente, Mme X, allait bien à 19h à son réveil.
L'IDE vous appelle car la patiente a des douleurs importantes.

Voici la fiche médicale de la patiente :

- ATCD : Aucun
- Traitements à l'admission : aucun
- Allergies : Non connues
- Motif d'admission et anamnèse : Femme de 30 ans ayant subi un accident de travail : une chute de 4 mètres dû à un échafaudage défectueux ce matin vers 9h. Au bilan lésionnel, on retrouve une fracture des deux os de la jambe à gauche. Le bodyscanner ainsi que l'examen clinique ne retrouvent pas d'autres lésions.
- Intervention dans l'après-midi : ostéosynthèse tibiale gauche par enclouage centromédullaire
- Consignes post-opératoires :
    - Pas d'attelle/plâtre, reverticalisation autorisée dès J1 avec un appui partiel sur le membre inférieur gauche.
    - Pansements tous les deux jours.
- Prescriptions :
    - Analgésie par paliers 1 + 3.
    - Anticoagulation préventive à débuter demain.

Consignes :

Vous avez 8 minutes pour :

- Examiner la patiente
- Enoncer à l'examinateur la principale hypothèse diagnostique
- Proposer à l'examinateur une conduite à tenir dans l'immédiat

Vous ne devez pas :

- Rédiger une prescription précise
- Faire une annonce / expliquer le diagnostic à la patiente

Attention : Vous avez 8 minutes incluant la lecture de ces consignes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec patient standardisé.

ECOS TACFA			
GRILLE D'ÉVALUATION			
Aptitudes cliniques			
1.	Prise des constantes vitales (point si demande les 5 : °C PA FC Saturation et O2 fréquence respiratoire).	2 pt	☐
2	Caractérise la douleur : (compter dès 2 éléments) - Localisation - Type de douleur - Mode de survenue brutal/progressif - Intensité / évolutivité / coter EVA ou EN	1 pt dès que cite 2 éléments	☐
3	Évalue l'analgésie préalable : - Horaire des dernières prises de morphiniques - Type d'anesthésie au bloc opératoire	1 pt	☐
4	Examiner les deux jambes de manière comparative	1 pt	☐
5	Rechercher une augmentation du volume de la jambe / une déformation visuelle évidente	1 pt	☐
6	Douleur à la palpation des loges musculaires et/ou à l'étirement des muscles (dorsiflexion de cheville)	1 pt	☐
7	Rechercher une tension dans les loges musculaires	1 pt	☐
8	Rechercher un déficit neurologique : Moteur : mobilisation des orteils et de la cheville ; Sensibilité de la jambe et notamment de la face dorsale de la première commissure	2 pt	☐
9	Rechercher une ischémie Prendre les pouls tibiaux postérieures et pédieux Rechercher une pâleur du membre Rechercher une froideur à la palpation	1 pt	☐
10	Rechercher des signes de MTEV : circulation collatérale veineuse augmentée de volume, douleur sur un trajet veineux, perte du ballant du mollet, dyspnée, toux, hémoptysie, douleur thoracique (signe de Homans et œdème non fiable dans ce contexte).	1 pt	☐
11	Regarde les pansements de la jambe	1 pt	☐
12	Annonce l'hypothèse de syndrome des loges	1 pt	☐
13	Mise à jeun / recherche l'heure du dernier repas	1 pt	☐
14	Appelle l'anesthésiste et le chirurgien de garde	1 pt	☐
15	Aponévrotomie en urgence	1 pt	☐
Communications et attitudes			

9. APTITUDE À STRUCTURER L'EXAMEN CLINIQUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
L'examen clinique est incomplet et désorganisé ou ne fait pas l'examen clinique	Les éléments recherchés sont peu ciblés, s'attarde à des manœuvres inutiles	L'examen clinique est raisonnablement organisé et couvre les éléments essentiels	L'examen clinique suit un enchaînement logique et est centré sur le problème, il n'y a pas de manœuvre inutile	L'examen est réalisé sans erreur avec un but précis, démarche intégrée

10. APTITUDE À MENER L'EXAMEN CLINIQUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'explique pas au patient les gestes réalisés ou ne respecte pas le confort du patient	Explique peu les gestes réalisés	Explique les gestes réalisés et respecte le confort du patient	Donne l'information sur les gestes en expliquant les objectifs /les éléments recherchés et respecte le confort du patient	Agit sans erreur Met à l'aise

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

TOTAL	….**/18 points**

Éléments de rétroaction :

Les douleurs post opératoires s'évaluent comme toute autre douleur, il faut cependant ajouter quelques éléments à votre analyse :

- Evaluer les analgésies notament les ALR
- Évaluer le contexte (sédation profonde, malade de réanimation etc…
- Rechercher des complications des contextes chirurgicaux : MTEV pour tous, Confusion chez les sujets âgés
- Rechercher des complications anesthésiques selon les contextes (ischémie myocardiques / AVC chez les sujets âgés et ou athéromateux, décompensation cardiaque etc…)
- Et c'est évidement un contexte de chirurgie donc il faut regarder les pansements et les drains, se renseigner sur le déroulé de l'intervention et les consignes post opératoires, rechercher des complications chirurgicales et notamment le syndrome des loges ou la dévascularisation.

Dans ce contexte précis, il faut avoir évoquer un syndrome des loges : le contexte de fracture fermée, des deux os de la jambe ou de l'avant-bras, d'enclouage centromédullaire, de traumatisme à haute cinétique ou par écrasement ou par choc direct les principaux facteurs favorisants

- La douleur d'un syndrome des loges est morphinorésistante, mais elle peut céder sous ALR, la jambe est augmentée de volume, parfois luisante ou réfléchissant la lumière mieux que l'autre jambe / segment de membre, la douleur est augmentée lors de l'étirement passif des muscles du segment de membre et à la palpation des loges musculaires qui sont tendues
- PIÈGE / ! \ : Le syndrome des loges est une ischémie capillaire initialement donc les pouls peuvent être préservés !!
- La situation dans laquelle les pouls sont abolis est le syndrome des loges secondaire à une ischémie de jambe, l'abolition des pouls peut donc être la cause d'un syndrome de loge plutôt que sa conséquence

Concernant la MTEV post opératoire :

- Elle peut survenir sous anticoagulant préventif comme curatif !
- Il faut y penser en contexte chirurgical en particulier s'il est traumatologique, orthopédique, oncologique ou infectieux +++
- Rechercher des signes de TVP doit toujours faire chercher des signes d'EP et inversement
- PIÈGE D'ORTHOPÉDIE / ! \ toujours faire attention aux consignes d'immobilisation ! Si vous pensez à une TVP sous plâtre suite à une fracture du membre inférieur : ne faites pas de signe de Homans : vous risquez de déplacer les os du patient !!

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds-« je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Vous êtes une jeune femme qui a chuté d'un échafaudage défectueux ce matin au travail et vous êtes cassé la jambe gauche, vous avez été opérée dans la journée.
Initialement vous n'aviez aucun déficit neurologique ou vasculaire et la fracture était bien fermée.
Cela fait une heure et demi que vous avez cette douleur progressive à type de broiement / d'écrasement de la jambe gauche, EVA à 8/10.
Vous avez demandé des morphiniques dès le début de la douleur mais elle ne fait qu'empirer malgré leur prise il y a une heure
Vous vous souvenez avoir eu une anesthésie loco-régionale avec une piqûre sous échographie au pli de l'aine en début de journée peu de temps après votre arrivée, que l'anesthésiste vous a dit qu'elle durait souvent 12h

Plan de la station ECOS : Patiente allongée dans un lit dans une chambre d'hospitalisation

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

Docteur j'ai terriblement mal, faites quelque chose ! Je n'ai jamais ressenti une telle douleur de ma vie !

Identité du patient : Mme X, femme jeune

Mode de vie : Vous êtes inspectrice en sécurité des travaux public et visitait un chantier quand l'accident est arrivé
Comportement global : Vous souffrez, espérez que le médecin va vous soulager, cette douleur vous inquiète, vous sentez que quelque chose ne va pas.
Antécédents personnels : Aucun
Antécédents familiaux : Aucun
Médicaments : Aucun
Symptômes positifs :

Douleur :
Délai 1h30, Morphine il y a 1h EVA 8/10, Broiement/écrasement
ALR réalisée à 30 minutes de l'arrivée, l'anesthésiste vous a dit qu'elle durerait moins de 12h
Peau : fermée, peau luisante, pansements propres
Vasculaire : pouls présents
Nerveux : Anesthésie de la 1ere commissure du pied opéré, pas de déficit moteur
Douleur à la palpation des loges et à l'étirement des muscles / mobilisation
Jambe augmentée de volume, loge tendues, peau luisante

Constantes : PA 150/70, 105 BPM, 99% AA, FR 16, 37,5°C
Donnée complémentaire : Aucune
Questions de relance :

Si pas de diagnostic à 6 minutes : Docteur qu'est-ce qu'il m'arrive ?
Si pas de traitement à 7 minutes : Il faut me réopérer docteur ?

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR

Plan de la station ECOS :

Patiente allongée sur un lit dans une chambre d'hôpital

Matériel nécessaire à la station :

- IPAD pour examinateur
- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur

Documents présents dans la station :

- Feuilles d’évaluation de papier de secours